

전립선암 진단 첫 30일

위험군 · 능동감시 · 수술과 방사선 선택

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 07

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

전립선암은 ‘위험군’에 따라 지켜보기부터 적극적 치료까지 길이 넓습니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Prostate Cancer, Version 7.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **⚡ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: PSA 상승과 암 확진, 능동감시와 대기관찰

30초 요약

- **PSA가 높다 ≠ 암.** 전립선비대증·염증으로도 오릅니다. 확진은 조직검사로 합니다.
- 치료는 **위험군**(저·중간·고·초고위험, 일부 지침은 저위험 안에 초저위험을 따로 구분)에 따라 달라집니다. 최근 개정에서 위험군 구분이 일부 바뀌어 오래된 자료와 다를 수 있습니다.
- **능동감시**(정기 검사로 지켜보다 필요할 때 근치 치료)와 **대기관찰**(증상이 생길 때 증상 치료)은 다른 전략입니다. 국내 병원·자료에서는 능동감시를 '**적극적 관찰(치료)**'이라고 부르기도 하고 두 말을 섞어 쓰기도 하니, "정기 MRI·조직검사를 하다가 근치 치료로 넘어가는 방식인가요?"라고 확인하세요.
- 수술과 방사선은 적합한 환자에서 **성적이 비슷하고 부작용 양상이 다릅니다.** 우열이 아니라 나에게 맞는 선택입니다.

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사 결과(등급군·양성 코어 수) 확인, MRI 시행 시점 확인	Day 0-3
②	위험군 판정, 필요 시 병기 검사(PSMA PET 등)	Day 3-14
③	배선 유전검사 대상 여부	첫 진료
④	능동감시 / 수술 / 방사선(± 호르몬) 결정 — 양쪽 진료과 상담	Day 10-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 등급군과 위험군은 무엇인가요?
2. 능동감시가 가능한가요?
3. 수술과 방사선을 모두 상담받을 수 있나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- 조직검사 후 38°C 이상 발열·오한(감염, 패혈증 가능성), 소변을 전혀 못 봄, 많은 혈뇨·핏덩이
- 소변이 막혀 아랫배가 부풀고 아픔
- 첫 호르몬 주사 후 1~2주 뼈 통증 악화·다리 힘 빠짐·소변 막힘(플레이어 현상)
- 등 통증 + 다리 힘 빠짐·감각 저하·대소변 장애(척수 압박)
- 항암 중 38°C 이상 발열
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 조직검사 후 소량의 혈뇨·혈정액·혈변은 몇 주간 흔합니다. 그러나 **발열·오한, 소변 막힘, 많은 출혈**은 바로 연락합니다. 직장을 거쳐 하는 조직검사 뒤 패혈증이 약 2%에서 생길 수 있고, 회음부로 하는 방법은 감염 위험이 더 낮다고 알려져 있습니다. 재조직검사를 받게 되면 어떤 방법인지 물어보세요.
2. 요폐는 도뇨가 필요합니다.
3. 일부 호르몬 주사(작용제)는 초기에 일시적으로 남성호르몬이 오르며 증상이 악화될 수 있어, 이를 막는 약을 먼저 쓰기도 합니다. 이런 현상이 없는 종류도 있으니 내 약이 어떤 종류인지 물어보세요.
4. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과지 받기 ② 복용 약(특히 전립선비대증·탈모약) 정리 ③ 배우자·파트너와 함께 진료받을지 정하기.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 — 등급군(Grade Group), 양성 코어 수와 비율
- ☐ **5알파환원효소억제제**(전립선비대증·탈모약: 피나스테리드·두타스테리드 등) 복용 여부와 기간 기록 — **PSA가 약 절반 정도로 낮게 측정될 수 있습니다**
- ☐ 배우자·파트너와 동반 진료 정하기 — 기능 결과(배뇨·성기능) 결정에 도움이 됩니다

이번 주 할 일

- ☐ 전립선 MRI가 조직검사 **전/후** 언제 시행됐는지 확인(없다면 추가 필요 여부 질문)
- ☐ 조직검사 전 MRI와 PSMA PET/CT는 2022년부터 일부 조건에서 건강보험 급여가 됩니다. 내 경우 급여 대상인지 담당의·원무과에 확인(2026.10 기준, 확인 필요)
- ☐ 가족력(전립선·유방·난소·췌장암) 정리 → **배선 유전검사** 대상 여부(고위험·전이·가족력)
- ☐ 산정특례 신청(C61, 확진일로부터 30일 이내; 능동감시를 하더라도 조직검사로 확진되면 신청할 수 있는지 원무과 확인)

오늘 물어볼 질문

1. 제 PSA와 MRI, 조직검사 결과를 어떻게 종합하나요?
2. 추가 병기 검사가 필요한가요?
3. 유전검사 대상인가요?

4장. 등급군과 위험군

30초 요약:

글리슨 점수는 현재 **등급군(GG) 1~5**로 표기합니다. 위험군은 PSA·등급군·병기(T)·양성 코어 수로 정합니다.

등급군	글리슨 점수	위운 뜻
GG1	3+3=6	가장 낮은 등급
GG2	3+4=7	낮은~중간
GG3	4+3=7	중간
GG4	8 (4+4, 3+5, 5+3)	높음
GG5	9~10	가장 높음

위험군(개념)	흔한 선택지
저위험(일부 지침의 초저위험 포함)	능동감시가 우선 권고되는 경우가 많음 , 수술·방사선도 가능
중간위험(양호/불량)	양호한 일부는 능동감시, 수술 또는 방사선(± 단기 호르몬)
고위험·초고위험	수술(± 추가치료) 또는 방사선 + 장기 호르몬, 초고위험 일부는 2세대 항안드로겐제(ARPI) 병용 범주
림프절 전이	방사선 + 호르몬(± ARPI) 등
원격전이	호르몬치료 + ARPI ± 항암

- PSMA PET에서 보이는 것이 곧 확정 전이는 아닙니다. 판독 표현(의심/가능성/확실)을 그대로 적고 치료 방향이 바뀌는지 확인하세요.

내 병리보고서에서 찾을 단어

단어	뜻
Grade Group / Gleason	등급
cores positive 3/12	12개 중 3개 양성
% of core	코어 안 암 비율
perineural invasion	신경 주위 침범
cribriform / intraductal	공격성과 관련된 소견 — 능동감시 판단에 영향

수술 후 병리에서

절제면 양성, 정낭 침범, 림프절 전이, 수술 후 PSA가 충분히 떨어지지 않음 → 추가 방사선(± 호르몬)을 상의하는 계기가 됩니다.

내 기록: PSA _ · 5알파환원효소억제제 ☐없음 ☐복용(_개월) · MRI(PI-RADS) _ · GG _ · 양성 코어 _/_ · 위험군 _ · PSMA PET _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 능동감시

30초 요약: 저위험(및 양호한 중간위험 일부)은 능동감시가 표준 선택지입니다. 정기 PSA·MRI·재조직검사로 지켜보다가 **등급 상승·MRI 변화** 등이 있으면 근처 치료로 넘어갑니다.

- 능동감시 중에도 언제든지 치료를 원하면 상의할 수 있습니다.
- 국소치료(병변만 태우거나 열리는 치료)는 아직 표준 대체 치료로 일상적으로 쓰지 않으므로 신중히 상의합니다.

일정 예시(병원마다 다름)

항목	간격 예시
PSA	6개월마다
직장수지검사	1년마다
MRI	1~2년마다 또는 변화 시
재조직검사	1~2년 안 확인, 이후 필요 시

날짜	PSA	MRI	조직검사	결정
----	-----	-----	------	----

감시가 길어질수록 "이대로 괜찮나" 하는 불안이 올 수 있습니다. 검사 결과 날짜를 미리 알고, 불안이 크면 그것도 상담의 이유가 됩니다.

6장. 수술 vs 방사선

30초 요약: 수술과 방사선이 모두 가능하면 **비뇨의학과와 방사선종양학과 양쪽 상담(또는 다학제 진료)**을 요청할 수 있습니다. 방사선은 방법에 따라 **5회 정도부터 수주**까지 통원 횟수가 다양합니다.

- 수술 뒤에는 정액이 만들어지지 않아 오르가즘은 느껴도 사정은 되지 않고, 자연 임신이 어렵습니다. 방사선·호르몬치료도 생식 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 자녀 계획이 있다면 **치료 전에 정자 보관**을 상의하세요.

비교 (범주)	근치적 전립선절제술(로봇 등)	방사선(± 호르몬)
배뇨	초기 요실금이 흔하고 대부분 수개월~1년에 걸쳐 회복	빈뇨·급박뇨 등 자극 증상
성기능	발기 기능 저하 흔함(신경 보존 여부 ·나이에 따라)	서서히 저하될 수 있음
장	영향 적음	직장 자극·출혈 가능
통원	입원 수일	5회~수주 통원
호르몬 비용	보통 없음	위험군에 따라 단기~장기
호르몬 비용	보통 없음	위험군에 따라 약 6개월(불량 중간위험)~18~36개월(고위험)

내 결정 워크시트

나에게 중요한 것(1~5점)	점수
요실금을 피하고 싶다	

나에게 중요한 것(1~5점)	점수
성기능 유지	
장 증상 피하기	
통원 부담	
호르몬치료 피하기	
수술에 대한 두려움	

수술이 정해지면: 골반저근 운동 4주

- 소변을 중간에 멈추는 근육을 찾아 **5초 조이고 5초 쉬기 × 10회, 하루 3번.**
수술 전부터 배워 두면 회복에 도움이 됩니다(병원 재활·비뇨기 간호 교육 문의).
- 요실금 패드는 흡수량별로 준비하고, 외출 시 여분을 챙깁니다.

방사선 방법

방법	횟수 감각
일반 분할	약 8~9주
중등도 저분할	약 4~6주
정위체부방사선 (SBRT)	약 5회
근접치료	단독 또는 외부방사선과 병합
입자치료(양성자· 중입자)	중입자는 주 4회 약 3주(12회) — 국내 일부 병원에서 시행, 적응· 비용·급여 여부 확인

7장. 호르몬치료(ADT)

30초 요약: 남성호르몬을 낮추는 치료로, 방사선과 함께(고위험) 또는 전이성에서 씁니다. 안면홍조·피로·근육 감소·체중 증가·성욕 저하·**뼈 약화**·기분 변화가 흔합니다.

- **주 2회 이상 근력운동 + 걷기** 등 유산소가 부작용을 줄입니다. 뼈 전이가 있으면 운동 제한을 확인하세요.
- 뼈 보호 주사를 권유받으면 **시작 전 치과 검진**을 받고, 발치 등 치과치료 전 담당의에게 알려세요.
- 기분·수면·기억력 변화도 말해도 되는 부작용입니다.

8장. 전이성 전립선암

30초 요약: 전이성 **호르몬감수성** 전립선암은 **호르몬치료 + 2세대 항안드로겐제(ARPI)** ± 항암(삼제) 범주가 표준입니다. 이후 **거세저항성**이 되면 PARP 억제제(유전자 변이 시)·방사성리간드치료·항암 등 후속 범주가 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요).

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료**는 **마지막 단계의 돌봄이 아닙니다**. 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 전립선암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요? 아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)

- □ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- □ 영상 CD + 판독지
- □ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- □ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 조직검사 결과지 ☐ 복용 약(5알파환원효소억제제) ☐ 동반 진료 결정 ☐ 연락처 저장

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ MRI 확인 ☐ PSMA PET 등(고위험) ☐ 유전검사 상담 ☐ 산정특례 문의

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 위험군 설명 ☐ 비뇨의학과·방사선종양학과 양쪽 상담 ☐ 결정 워크시트

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 골반저근 운동 ☐ 패드 준비 ☐ 호르몬치료 시 치과·골밀도 ☐ 직장 일정

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 능동감시 일정 확정 또는 치료 시작 ☐ 배뇨·기분 일지 ☐ 첫 호르몬 주사 후 주의 증상 확인
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

남성성·성기능·관계

30초 요약: 배뇨·성기능 변화와 남성성에 대한 걱정은 흔하며, 의료진에게 말하는 것이 자연스러운 일입니다. 발기부전 치료(약·주사·기구·보형물)와 성재활이 있습니다. 배우자·파트너와 함께 진료받는 것을 권합니다.

- "몸이 변하는 게 두려워. 같이 방법을 찾아보자." — 친밀감은 성관계만이 아닙니다.

호르몬치료(ADT) 중 기분·기억 기록(주 1회)

주	기분 0~10	잠	기억·집중	안면홍조
---	---------	---	-------	------

추적

- 치료 후 PSA를 정기적으로 확인합니다. 수술 후에는 PSA가 거의 0으로, 방사선 후에는 서서히 떨어집니다. **PSA 재상승**은 영상 등으로 확인하며, 곧바로 증상이 있는 재발을 뜻하지는 않습니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 옳은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
- 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
- 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
- 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(전립선암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

전립선암 참고: 질병코드는 C61입니다. 로봇수술은 비급여 부분이 있어
병원별 비용 차이가 큼니다. 실손보험 적용 여부와 예상 비용을 원무과에 미리
확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 등급군과 양성 코어 수는요? 2. 위험군은 무엇인가요? 3. MRI·PSMA PET이 필요한가요? 4. 능동감시가 가능한가요? 5. 수술과 방사선 양쪽 상담을 받을 수 있나요? 6. 각 치료의 배뇨·성기능·장 영향은요? 7. 호르몬치료가 필요하다면 기간은요? 8. 유전검사 대상인가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 치료 후 PSA는 어떻게 추적하나요?

내 전립선암 한 장 요약

항목	내 기록
PSA(진단 시)	_____ (5알파환원효소억제제 □)
등급군	GG _____
양성 코어	___/___
MRI / PSMA PET	___/___
위험군	_____
첫 치료	능동감시 / 수술 / 방사선 ± 호르몬 / 전신치료
유전검사	_____
산정특례	□신청 □완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 위험군은? ② 능동감시가 가능한가요? ③ 수술과 방사선의 차이는 제게 어떤 의미인가요?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

66세 영호 씨 — 저위험, 능동감시 "아무것도 안 하는 게 맞냐"고 세 번 물었다. 담당의는 감시도 치료 전략이며 일정이 정해져 있다고 설명했다. 기록표에 PSA를 적기 시작하자 불안이 조금씩 줄었다. "지켜보는 것도 제가 선택한 치료라는 걸 알게 됐어요."

59세 성민 씨 — 중간위험, 수술 vs 방사선 아내와 함께 두 진료과를 다 만났다. 결정 워크시트에 요실금과 통원 부담 점수를 적고 나니 답이 보였다. "둘 다 맞는 길이라서 오히려 고르기 어려웠는데, 우리 부부에게 중요한 걸 적으니 정리됐어요."

72세 덕수 씨 — 전이성 호르몬감수성 첫 호르몬 주사 후 주의할 증상을 냉장고에 붙였다. 뼈 주사 전 치과 검진을 받았고, 주 2회 근력운동을 시작했다. "약만 먹는 게 아니라 제가 할 일이 있다는 게 힘이 되었습니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
PSA	전립선 특이항원. 암 외에도 오를 수 있음
등급군(GG) / 글리스 점수	암세포 공격성 등급
PI-RADS	MRI 의심 정도 등급
PSMA PET	전립선암 세포를 찾는 PET
능동감시 / 대기관찰	근치 치료를 염두에 둔 관찰 / 증상 생기면 증상 치료

용어	쉬운 뜻
근치적 전립선절제술	전립선 전체 제거
ADT(호르몬치료)	남성호르몬을 낮추는 치료
ARPI	2세대 항안드로겐제
호르몬감수성 / 거세저항성	호르몬치료에 반응 / 반응이 떨어짐
플레어 현상	호르몬 주사 초기 일시적 악화
5알파환원효소억제제	전립선비대증·탈모약. PSA를 낮춤

자주 묻는 질문 12

Q1. PSA가 다시 올라가면 재발인가요? 수치의 크기와 오르는 속도, 영상을 함께 봅니다. PSA만 오르는 "생화학적 재발"은 곧바로 증상이 있는 재발을 뜻하지 않으며, 추가 방사선 등 선택지가 있습니다.

Q2. 능동감시를 하다 치료 시기를 놓치지 않을까요? 정기 PSA·MRI·재조직검사로 변화가 있으면 근치 치료로 넘어갑니다. 대규모 연구에서 적절한 감시 대상자의 장기 전립선암 사망률은 즉시 치료와 큰 차이가 없었습니다. 다만 진행·전이는 감시군에서 다소 많았던 결과도 있어, 정해진 검사 일정을 지키는 것이 중요합니다.

Q3. 로봇수술이 개복보다 낫나요? 출혈·회복 기간에 장점이 있을 수 있으나, 장기적인 암 치료 결과와 기능 결과는 **수술자의 경험**이 더 중요하다는 견해가 많습니다.

Q4. 수술 후 요실금은 얼마나 가나요? 국내 자료로는 6개월 안에 약 80~90%, 1년 안에 95% 이상이 일상에 지장 없는 정도로 좋아집니다. 골반저근 운동은 수술 전부터 시작해 수술 뒤 6~12개월 꾸준히 하면 도움이 됩니다. 1년 이상 지속되면 추가 치료 선택지가 있습니다.

Q5. 발기 기능은 회복되나요? 신경 보존 여부, 나이, 수술 전 기능에 따라 다릅니다. 약·주사·기구·보형물 등 재활 방법이 있으니 일찍 상의하세요.

Q6. 방사선치료를 받으면 몸에서 방사선이 나오나요? 외부방사선은 몸에 남지 않습니다. 영구 삽입 근접치료는 초기 일정 기간 어린이·임신부와 가까운 접촉을 줄이도록 안내받을 수 있습니다.

Q7. 호르몬치료를 받으면 남성성이 사라지나요? 성욕 저하·안면홍조·근육 감소가 흔하지만, 운동과 관리로 줄일 수 있습니다. 감정 변화도 의료진에게 말해 주세요.

Q8. 아들도 검사를 받아야 하나요? 가족력이 있으면 아들·형제는 더 일찍 PSA 상담을 받는 것이 좋습니다. BRCA2 등 변이가 확인되면 유전상담을 권합니다.

Q9. 전립선비대증 약을 계속 먹어도 되나요? 대부분 계속 먹을 수 있지만, 5알파환원효소억제제는 PSA를 낮추므로 복용 사실을 꼭 의료진에게 알려 주세요.

Q10. 자전거 타거나 성관계가 PSA에 영향을 주나요? 검사 직전 격한 자전거 타기·사정은 PSA를 일시적으로 올릴 수 있어, 검사 1~2일 전에는 피하라고 안내하기도 합니다.

Q11. 뼈 전이가 있으면 걷기 운동이 위험한가요? 전이 위치에 따라 다릅니다. 골절 위험을 평가한 뒤 안전한 운동 범위를 정하세요.

Q12. 국소치료(병변만 태우는 치료)는 어떤가요? 일부 센터에서 시행하지만 아직 표준 대체 치료로 일상적으로 권하지 않습니다. 장기 근거와 추적 방법을 꼼꼼히 확인하세요.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩

- 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	

항목	기록
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(🕒)
1주(Day 0-7)		

주	날짜	한 일(✔) / 남은 일(⌚)
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Prostate Cancer, Version 7.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 전립선암 정보, 대한비뇨의학회·대한비뇨기종양학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 전립선암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
 - 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>